

Eozinofilik Özofajit

Kronik, immün/antijen aracılı özofagus hastalığında tanı doğrulama, PPI ve topikal steroidin dozlu kullanımı, eliminasyon diyeti ve dilatasyon kararlarını kapsayan basamaklı karar aracı.

Disfaji · İmpaksiyon

Özofagus ≥ 15 eoz/BBA

PPI · Topikal steroid

Eliminasyon diyeti

01 Tanım ve İlk Değerlendirme

Eozinofilik özofajit (EoÖ), klinik olarak özofagus disfonksiyonu semptomları ve histolojik olarak özofagus mukozasında yoğun eozinofil infiltrasyonu (en yüksek büyütme alanında ≥ 15 eozinofil/BBA, yaklaşık ≥ 60 eoz/mm²) ile karakterize, antijen/immün aracılı kronik bir hastalıktır. Tanı klinik + endoskopik + histolojik verilerin bütünleştirilmesiyle konur; artık PPI yanıtı bir dışlama kriteri DEĞİLDİR, PPI bir tedavi seçeneğidir.

Öykü — Yaşa Göre Semptomlar

- Süt çocuğu/oyun çocuğu: beslenme reddi, kusma, regürjitasyon, büyüme geriliği, iritabilite
- Okul çocuğu: karın/göğüs ağrısı, kusma, bulantı, tedaviye dirençli reflü benzeri şikayetler
- Adölesan: disfaji, yavaş yeme, çok çiğneme/su ile yutma, besin impaksiyonu
- Uyum davranışları (dikkat): iri lokmalardan kaçınma, en son yemek bitirme, sos/su ile ıslatma
- Atopi eş tanısı: astım, alerjik rinit, atopik dermatit, IgE aracılı besin alerjisi, aile öyküsü

Muayene ve İlk Tetkik

- Fizik muayene sıklıkla normal; büyüme parametreleri (persentil, tartı-boy) mutlaka değerlendirir
- Atopik bulgular: egzama, alerjik shiner, oral solunum
- Akut besin impaksiyonu acildir → endoskopik çıkarım + aynı seansta biyopsi
- Üst GİS endoskopisi ilk basamak: özofagus boyunca 2-4 farklı düzeyden (proksimal + distal) ≥ 6 biyopsi
- Rutin periferik eozinofili/serum IgE tanı koydurucu değildir; alerji testleri diyet hedefleme için sınırlı yarar

Endoskopik bulgular normal görünse bile (%10-30 makroskopik normal) biyopsi zorunludur. EREFS skoru (ödem, halkalar/trakealizasyon, eksüda, longitudinal oluklar, striktür) endoskopik şiddeti standardize eder.

EoÖ, genetik yatkın bireyde gıda (nadiren aeroalerjen) antijenlerine karşı gelişen Th2 baskın, IgE-bağımsız gecikmiş tipte bir inflamasyondur. Anahtar sitokinler ve bariyer bozukluğu kronik fibrozis ve strüktürel remodeling ile sonuçlanır.

Antijenik Tetik

- Süt, buğday, yumurta, soya en sık tetikleyiciler
- Fıstık/ağaç yemişi, deniz ürünleri daha az
- Mekanizma IgE-bağımsız, gecikmiş T-hücre aracılı

Th2 İnflamasyon

- IL-13, IL-5, IL-4 aşırı ekspresyonu
- Eotaksin-3 (CCL26) ile eozinofil kemotaksisi
- Mast hücre ve bazofil katkısı

Epitel Bariyer Bozukluğu

- Filaggrin/DSG1 azalması, geçirgenlik artışı
- TSLP ve CAPN14 gen ilişkisi
- Antijen penetrasyonunun kolaylaşması

Doku Remodeling

- TGF- β aracılı subepitelyal fibrozis
- Lamina propria kollajen birikimi
- Düz kas hipertrofisi ve motilite bozukluğu

Klinik Fenotip

- İnflamatuvar fenotip (ödem, eksüda) — genç çocuk
- Fibrostenotik fenotip (halka, striktür) — adölesan
- Tanı gecikmesi fibrozis riskini artırır

Eş Hastalıklar

- Atopik yürüyüş: egzama, astım, rinit
- IgE aracılı besin alerjisi birlikteliği
- Bağı dokusu hastalıkları ile ilişki (nadir)

Semptomatik hastada tanıyı histolojik olarak doğrula, ardından ilk basamak tedaviyi (PPI, topikal steroid veya eliminasyon diyeti) seç ve 8-12 haftada endoskopik/histolojik yeniden değerlendirme ile yanıtı objektif kanıtla.

BAŞLANGIÇ**Özofagus disfonksiyonu semptomları**

Disfaji, besin impaksiyonu, tedaviye dirençli reflü, beslenme reddi veya büyüme geriliği olan çocuk.

ADIM 1**Üst GiS endoskopisi + segmental biyopsi**

Proksimal ve distal özofagustan ≥ 6 biyopsi; mide ve duodenum biyopsileri ile diğer eozinofilik/GÖRH nedenlerini dışla.

KARAR 1**Pik ≥ 15 eozinofil/BBA var mı?**

Histolojik eşik sağlanıyor ve sekonder nedenler (GÖRH-dışı, akalazya, Crohn, enfeksiyon, hipereozinofilik sendrom) dışlanmış mı?

HAYIR → Alternatif tanı

EVET → EoÖ tanısı

YENİDEN DEĞERLENDİR**GÖRH / diğer nedenler**

Semptom sürüyorsa GÖRH yönetimi, pH-impedans veya diğer eozinofilik GiS hastalığı araştırması.

KARAR 2**İlk basamak tedavi seçimi**

Aile tercihi, fenotip ve uygulanabilirliğe göre PPI, yutulan topikal steroid veya eliminasyon diyetinden biri.

ADIM 2**Seçilen tedaviyi 8-12 hafta uygula**

PPI, budesonid/flutikazon ya da 6/4/2/1-gıda eliminasyonu; tedaviye tam uyum ve süreyi sağla.

KARAR 3**Kontrol endoskopide histolojik remisyon (<15 eoz/BBA)?**

Semptom düzelmesi tek başına yeterli değil; yanıt histolojik olarak kanıtlanmalı.

EVET → İdame

SÜRDÜR

En düşük etkili doz ile idame

Etkili tedaviyi sürdür, periyodik izlem; ilaç kesilmesi sıklıkla nüksle sonuçlanır.

HAYIR → Basamak yükselt

YENİDEN DÜZENLE

Tedaviyi değiştir / dilatasyonu değerlendir

Alternatif ajana geç, dozu optimize et, uyumu sorgula; darlık + disfaji varsa endoskopik dilatasyon ekle.

04 Basamaklı Tetkik

Tanı doğrulama ve tedavi yanıtının izlenmesi endoskopik-histolojik temellidir; kan testleri ve görüntüleme tamamlayıcıdır.

EoÖ tanı ve izlem basamakları		
BASAMAK	YÖNTEM/DOZ	AMAÇ VE NOT
1. Üst GİS endoskopisi	Proksimal + distal ≥6 biyopsi	EREFS skorlaması; ödem, halkalar, eksüda, oluklar, striktür kaydı
2. Histopatoloji	Pik eozinofil sayımı /BBA	≥15 eoz/BBA tanısız; bazal tabaka hiperplazisi, mikroabse, lamina propria fibrozisi
3. Gastrik/duodenal biyopsi	Rutin eşlik eden örnekleme	Eozinofilik gastrit/enterit ve diğer sistemik nedenleri dışla
4. Alerji değerlendirmesi	Öykü ± deri/sIgE testi	Atopi eş tanısı için; diyet hedeflemede öngörü değeri düşük
5. Kontrol endoskopi	Tedavinin 8-12. haftası	Histolojik remisyon (<15 eoz/BBA) objektif kanıtı; her tedavi değişiminde tekrar
6. Özofagogram (seçili)	Baryumlu grafi	Şüpheli ince/uzun darlık, small-caliber özofagus haritalaması

Aşağıdaki bulgular acil endoskopik girişim, hızlandırılmış tanı veya tedavi yoğunlaştırması gerektirir.

- Akut besin/yabancı cisim impaksiyonu — acil endoskopik çıkarım + biyopsi

- Tam disfaji, tükürüğü yutamama, dehidratasyon

- İlerleyici kilo kaybı / büyüme duraklaması / beslenme reddi

- Hematemez, delinme kuşkusu, şiddetli göğüs ağrısı (spontan perforasyon riski)

- Yüksek dereceli darlık / small-caliber özofagus

- Optimal tedaviye rağmen kalıcı histolojik aktivite (dirençli EoÖ)

Üç ilk basamak seçeneği (PPI, yutulan topikal steroid, eliminasyon diyeti) benzer histolojik remisyon hedefi taşır; seçim aile tercihi, fenotip ve uygulanabilirliğe göre bireyselleştirilir. Tedavi kroniktir; etkili ajan kesilirse nüks kuraldır. Dozlar günde ikiye bölünmüş şekilde verilir.

EoÖ ilaç ve girişim tedavileri (pediatrik dozlar)	
TEDAVİ	DOZ
PPI (omeprazol vb.)	1-2 mg/kg/gün, 2 doza böl (maks 40 mg/gün)
Yutulan flutikazon (ölçülü doz inhaler, yutulur)	Küçük çocuk 88-440 µg/gün; büyük çocuk 440-880 µg/gün
Yutulan budesonid (viskoz süspansiyon/orodispersibl)	<10 yaş 1 mg/gün; ≥10 yaş 2 mg/gün, 2 doza böl
Eliminasyon diyeti	6-/4-/2-/1-gıda basamaklı eliminasyon
Dupilumab (IL-4Rα)	≥1 yaş, kiloya göre (15-<30 kg 200 mg/2 hafta)
Endoskopik dilatasyon	Kademeli (rule of 3), semptomatik darlıkta

TEDAVİ	DOZ

Yutulan steroid sonrası ağzı su ile çalkalayıp tükürtmek özofageal/oral kandidiyaz riskini azaltır. Uzun süreli kullanımda oral kandidiyaz ve nadiren adrenal etkilenme açısından izlem yapılır.

Dilatasyon inflamasyonu tedavi etmez; mutlaka etkili medikal/diyet tedavi ile birlikte uygulanmalı. İşlem öncesi ve sonrası göğüs ağrısı beklenir; şiddetli-ısrarlı ağrı, ateş veya subkutan amfizemde perforasyon dışlanmalıdır.

Hedef: histolojik remisyon <15 eoz/BBA

İlk kontrol 8-12. hafta

Etkili tedaviyi sürdür

07 İzlem ve Yönetim İlkeleri

EoÖ ömür boyu kronik seyreder; tedavi hedefi hem semptom hem histolojik-endoskopik remisyondur ve idame ilaç kesilirse nüks beklenir. İzlem multidisipliner (gastroenteroloji, alerji, diyetisyen) yürütülür.

İzlem İlkeleri

- Her tedavi başlatma/değişiminde 8-12 hafta sonra kontrol endoskopi + biyopsi
- Semptom-histoloji uyumsuzluğu sık; kararı histolojiye dayandır
- Remisyonunda en düşük etkili idame doz; ilaç kesme genellikle nükse yol açar
- Büyüme, kilo, beslenme yeterliliği düzenli değerlendir; kısıtlayıcı diyetle diyetisyen desteği
- Yutulan steroidde oral/özofageal kandidiyaz taraması

Hasta/Aile Eğitimi

- Hastalığın kronik doğası ve tedavi devamlılığının önemi
- İlaç uygulama tekniği (steroidi yut, sonra 30 dk aç kal)
- Yavaş yeme, iyi çiğneme; impaksiyon acil başvuru işaretleri
- Diyet uygulanıyorsa gizli tetikleyiciler ve etiket okuma
- Atopik eş hastalıkların birlikte yönetimi

Kaynaklar

1. Dhar A, Haboubi HN, Attwood SE, et al. British Society of Gastroenterology and British Society of Paediatric Gastroenterology, Hepatology and Nutrition — guidelines on eosinophilic oesophagitis. Gut. 2022.
2. Hirano I, Chan ES, Rank MA, et al. AGA Institute and Joint Task Force on Allergy-Immunology Practice Parameters — Clinical Guidelines for the Management of Eosinophilic Esophagitis. Gastroenterology. 2020.
3. Lucendo AJ, Molina-Infante J, Arias Á, et al. Guidelines on eosinophilic esophagitis: evidence-based statements and recommendations (UEG/EAACI/ESPGHAN). United European Gastroenterol J. 2017.
4. Dellon ES, Liacouras CA, Molina-Infante J, et al. Updated International Consensus Diagnostic Criteria for Eosinophilic Esophagitis: AGREE Conference. Gastroenterology. 2018.

Uyarı: Bu belge pediyatrik gastroenteroloji uzmanları için hazırlanmış bir klinik karar destek aracıdır; yerel protokoller, güncel kılavuzlar ve hastanın bireysel klinik durumu doğrultusunda hekimin nihai kararının yerini tutmaz. Dozlar ilgili ilacın güncel prospektüsü ile teyit edilmelidir.